Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre - Saúde Suplementar

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - (51) 99500-0988 - Email: frpoacent15vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5153371-94.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: ARISTIDES MONTEIRO BORGES
ADVOGADO(A): ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA (OAB RS078452)

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
ADVOGADO(A): MARCELO CORREA DA SILVA (OAB RS032484)

SENTENÇA

ARISTIDES MONTEIRO BORGES ajuizou ação de obrigação de fazer contra **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.**

Narra que é beneficiário do plano de saúde e portador de Dermatite Atópica Grave e Extensa (CID 10 L20.9), Scorad: 76,69 e DLQI: 30, uma doença crônica e com grande prejuízo psicossocial, depressão, prurido intenso e incapacitante. Aduz que realizou tratamento com "upadacitinibe", por meio da liminar deferida no processo n.º 5116892-39.2023.8.21.0001, a qual foi suspensa por ausência do medicamento no rol da ANS. Diante da superação das terapias anteriores e do risco de crises, o médico do autor determinou a mudança do tratamento, sendo receitado o fármaco "DUPILUMABE" (Dupixent), 600mg, subcutâneo, na primeira aplicação, seguida de uma ampola a cada 14 dias. Refere que o medicamento possui indicação no rol da ANS para a doença do autor, entretanto, a medicação foi novamente negada pela UNIMED, sob a justificativa que o remédio não faz parte do rol de coberturas obrigatórias da ANS, bem como a solicitação não veio acompanhada de documentos comprobatórios de eficácia à luz da ciência da saúde. Em sede de tutela antecipada, postula a determinação para que o plano de saúde forneça o medicamento DUPILUMABE" (Dupixent), 600mg (4x 150mg), subcutâneo, na primeira aplicação, seguida de uma ampola a cada 14 dias. Juntou documentos.

Concedida a justiça gratuita e deferido o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar que: *"a ré forneça ao autor o medicamento DUPILUMABE (Dupixent), 600mg (4x 150mg), nos exatos termos do laudo médico (evento 1, LAUDO12), **no prazo máximo de 05 dias.** Fixo multa diária no valor de R$ 300,00, na hipótese de descumprimento do decisum, limitada inicialmente a trinta dias"* (3.1).

Citada, a ré apresentou contestação. Em preliminar, impugnou o valor da causa, postulando que seja fixado o valor de alçada. No mérito, requereu a improcedência, alegando a impossibilidade de condenação da ré ao fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS. Argumenta, ainda, que não foi demonstrado no processo que o autor não teria respondido a tratamento com outros medicamentos, bem como qualquer outra situação excepcional que autorizasse o deferimento do pleito. Impugnou a inversão do ônus da prova (11.1).

Houve réplica (14.1).

Intimadas as partes para produção de provas (16.1), nada mais foi requerido.

É o relatório. DECIDO.

I. Preliminar

A parte ré apresentou, em preliminar de contestação, impugnação ao valor da causa. Sustenta que o valor estipulado deve ser o de alçada, pois a *"saúde do autor, direito este cujo valor é inestimável, motivo pelo qual deve ser atribuído o valor da causa ao valor de alçada"*.

Os artigos 291 e 292 do CPC definem que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que o conteúdo econômico deste seja indeterminado, e as diretrizes para fixação desse valor, *in verbis*:

> *"Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.*
>
> *Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:*
>
> *I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;*
>
> *II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;*
>
> *III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;*
>
> *IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;*
>
> *V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;*
>
> *VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;*
>
> *VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;*

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes."

O propósito da presente ação é obrigação de fazer consistente no cumprimento do contrato pela operadora do plano de saúde, devendo ser atribuído à causa o valor de alçada.

Nesse sentido, destaco julgado do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE ESÔFAGO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RN 465/2021 Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula cobertura para o tratamento com o medicamento Keytruda® (Pembrolizumabe), visto que portadora de câncer de esôfago (CID C15.9), com disseminação de metástases linfonodais, julgada procedente na origem. Da Preliminar de Impugnação do valor da causa - O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico a ser auferido pela parte, em especial, quando este é passível de apuração e se mostra certo ante ao pedido formulado, nos termos dos artigos 291 e 292 do CPC. O propósito da ação é o cumprimento do contrato pela operadora do plano de saúde, de modo que, não há como estimar o proveito econômico a ser auferido, devendo ser atribuído à causa o valor de alçada. Preliminar acolhida. Do mérito - É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. A Lei nº 14.454/22 estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol (EREsp 1886929 e EREsp nº 1889704). 3) Das condicionantes fixadas pela Corte Superior para excepcionar o Rol da ANS, remanescem as constantes nos itens "ii" e "iii" - (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros. No caso dos autos, a parte autora objetiva a cobertura do medicamento "Pembrolizumabe", medicamento antineoplásico, para tratamento de câncer do esôfago, porém, teve o custeio e fornecimento negado por suposta utilização off label da medicação.Nesse contexto, em se tratando de medicamento antineoplásico, a exclusão de cobertura se mostra abusiva, pelo que a seguradora deve fornecer a medicação requerida nos precisos termos do laudo prescrito pelo médico responsável pelo tratamento.Ademais, havendo previsão de cobertura no Rol da ANS, ainda que para doença diversa, o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento previsto no Rol da ANS, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações de utilização do medicamento, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente gravemente enfermo.PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 5001140082024821005 8, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-02-2025)

Dessa forma, **impositivo o acolhimento da preliminar e atribuição do valor de alçada** .

II. Mérito

Nos termos da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

O autor foi diagnosticado com Dermatite Atópica Grave e Extensa (CID 10 L20.9), Scorad: 76,69 e DLQI: 30 - evento 1, LAUDO12. A condição de beneficiário do plano restou demonstrada, através da negativa de cobertura (evento 1, OUT11).

Os documentos trazidos, laudo médico (evento 1, LAUDO12), comprovação do medicamento no rol da ANS (evento 1, RES22) e tabela de preço regulamentada pela ANVISA (evento 1, TABELA20) **são suficientes para demonstrar a necessidade de prescrição do medicamento DUPILUMABE" (Dupixent), 600mg (4x 150mg).**

É incontroverso que a ré negou a cobertura do medicamento, todavia, também restou demonstrada a necessidade do medicamento pela parte atora e do seu uso para a qualidade de vida, além da expressa recomendação médica.

O tratamento necessário está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; e, inclusive, **em 02/04/2024** foi incluído no rol da ANS a ampliação do uso do medicamento **Dupilumabe** para tratamento de dermatite atópica. Portanto, obrigatório o fornecimento pelos planos de saúde, desde que preenchidos os critérios de elegibilidade, quais sejam:

(1) Laudo médico que indique se tratar de paciente "sem resposta adequada a tratamento tópico com corticosteroide e/ou inibidores de calcineurina por pelo menos 6 meses" e

(2) Índice de Gravidade da Dermatite Atópica (SCORing Atopic Dermatitis) - SCORAD superior a 50;

OU Índice de Severidade e Área de Eczema (Eczema Area and Severity Index) - EASI superior a 21;

*OU Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (Dermatology Life Quality Index) - **DLQI superior a 10**;*

OU Índice Pediátrico de Qualidade de Vida em Dermatologia (Children's Dermatology Life Quality Index- CDLQI superior a 12.

No caso específico, o laudo médico indicou tratar-se **DLQI 30 e Scorad 76,69** (evento 1, LAUDO12).

Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva cláusula que exclua o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano, indicado pelo médico especialista e cujo uso foi ampliado no rol da ANS.

Nesse sentido:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. **SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.** PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. **AGRAVANTE PORTADORA DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE. PEDIDO DE COBERTURA DO MEDICAMENTO DUPILUMABE.** É LÍCITA A EXCLUSÃO, NA SAÚDE SUPLEMENTAR, DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUELES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DE UNIDADE DE SAÚDE, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (E CORRELACIONADOS), A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) PARA ESSE FIM. **NO CASO EM EXAME, O FÁRMACO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA CONSTA DA RN-ANS Nº 465/2021 COMO MEDICAMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA O TRATAMENTO DA CONDIÇÃO, DE MODO QUE DEVE SER CUSTEADO PELO PLANO DE SAÚDE.** AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº 53884946120238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-04-2024)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT®). DERMATITE ATÓPICA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora busca cobertura para o tratamento de dermatite atópica (CID 10 L20.9) com medicamento denominado DUPILUMABE (Dupixent®), 200mg, a ser administrado em ambiente ambulatorial, visto que subcutâneo, julgada procedente na origem.** 2) A Lei nº 14.454/22 estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol (EREsp 1886929 e EREsp nº 1889704). 3) Das condicionantes fixadas pela Corte Superior para excepcionar o Rol da ANS, remanescem as constantes nos itens "ii" e "iii" - (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros. 4) Segundo entendimento do egrégio STJ, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. **5) No caso em comento, o tratamento indicado se trata de medicação imunobiológica endovenosa ou subcutânea e tem cobertura prevista no Rol da ANS para Dermatite Atópica, conforme previsto no Anexo II da RN nº 465/21, na Diretrizes de Utilização (DUT). 6) Sem razão a negativa de cobertura, visto que o medicamento, objeto da lide está incluído no rol da ANS.** Sentença mantida, no ponto. 7) O egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu, a partir do julgamento do TEMA 1076, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Da mesma forma, definiu que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Ficou sedimentado, ainda, o entendimento que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 8) Em alinhamento com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, fora publicada a recente Lei Federal n. 14.365, em 03/06/2022, que trouxe alterações ao CPC, com a inclusão do parágrafo 6º-A ao artigo 85, o qual veda de forma taxativa a aplicação da fixação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa for líquido, ou liquidável. 9) Assim, o recurso da parte autora resta provido, para fim de ser fixada a verba honorária na forma do art. 85, § 2º, do CPC. DUPLA APELAÇÃO. APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO(Apelação Cível, Nº 50024811720228210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-02-2024). **(grifei)

A parte autora comprovou a eficácia, baseada em evidências científicas e em plano terapêutico do medicamento ora pleiteado (evento 1, NOTATEC17, evento 1, NOTATEC18 e evento 1, NOTATEC19).

Ademais, havendo cobertura para a patologia apresentada, "*não cabe à operadora de plano de saúde eleger qual o procedimento a que deve ou não se submeter o beneficiário, indicação que cabe exclusivamente ao médico de confiança do paciente*" (AgInt no AREsp 1807169/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Para não passar em branco, em que pese a parte ré faça menção genérica acerca da existência de alternativas medicamentosas com eficácia para tratamento da doença que acomete o autor, não há nenhum elemento a dar amparo a tal alegação, tendo o médico responsável consignado no laudo a ineficácia de outros medicamentos no tratamento do paciente.

III. Dispositivo

Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de ratificar a tutela provisória e condenar a ré a **fornecer** o medicamento Dupilumabe 300mg, conforme prescrição médica, na posologia de *"02 seringas na primeira aplicação (600 mg), e em seguida, 01 seringa a cada 14 dias"*, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo da revisão do tratamento e mudança da posologia, de acordo com prescrição médica.

Condeno a **ré** ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao(s) procurador(es) da parte adversa, os quais fixo no percentual de **50% do valor da causa ora retificado**, devidamente corrigido pelo IPCA, desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (sem capitalização), contados a partir do trânsito em julgado desta decisão, considerando o tempo de duração do processo e a complexidade da causa, forte no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Tendo em vista que o §3º do art. 1.010 do CPC/2015 retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, caso interposto recurso de apelação, caberá ao Cartório, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC/2015. Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de recurso adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC/2015) e impugnação de decisão interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação (art. 1.009, § 2º, CPC). Após, concluídas as intimações e decorridos os prazos, havendo recurso, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Publicada, registrada e intimadas as partes, automaticamente, via sistema.

Com o trânsito, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉIA NEBENZAHL DE OLIVEIRA, Juiz de Direito**, em 12/09/2025, às 20:03:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10090890266v11** e o código CRC **1bc5c1e7**.